

Información Paciente

Nombre : Aixa Ainara Caro Miranda

Rut : 22.217.497-K

N° Archivo : 2119592

N° Epicrisis
467921

Edad : 19a 3m 13d

Fecha Nacto: 26/09/2006

Sexo : Femenino

Dirección : Canaan Uno Poniente 0289 Jesus De Naz

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 991472154

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 30/12/2025 00:20

Días Estadía : 9

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 08/01/2026 13:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

AMENAZA DE CRISIS MIASTÉNICA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR 30/12/25.

FI UTAC 30/12/25.

FI UPC 31/12/25

RE INGRESO UTAC 06/01/26

INGRESO SALA 08/01/26

Paciente diestra, mRs 2, con los siguientes antecedentes:

- Médicos: Miastenia gravis diagnosticada el año 2024, ac. anti-receptor acetilcolina (+)

- Quirúrgicos: Timectomía por VTC 26/05/25, recibió inmunoglobulinas previo a cirugía.

- Fármacos: Piridostigmina 60 mg 8-10 comp/día, prednisona 40 mg/día, azatioprina 50 mg 1 comprimidos AM - 2 comprimidos PM.

- Alergias: Látex.

- Hospitalizaciones recientes: 25/05 al 28/05 por timectomía, 30/05 al 09/06 por crisis miasténica, requirió IOT x 4 días, NAC aspirativa.

- Hábitos tóxicos: no refiere.

- Social: Completó cuarto medio, con planes de continuar estudios.

ANAMNESIS:

Paciente con antecedentes descritos, acude a consultar tras cuadro de 5 semanas de evolución caracterizado por paresia progresiva de extremidades, principalmente proximal a nivel apendicular y facial. En seguimiento por neurología ambulatoria, se indicaron pulsos de metilprednisolona 1 gr al día, completando 3 gr el 28/12/25. Reevaluada por neuróloga tratante, evolucionó con progresión de debilidad tras los pulsos de corticoides, motivo por el cual se derivó al servicio de urgencia el 29/12.

Al interrogatorio dirigido, sin síntomas gastrointestinales, respiratorios ni urinarios, sin fiebre. Buena adherencia a tratamiento. Tampoco refiere haber tomado fármacos descompensantes, esfuerzo físico extenuante ni otros factores descompensantes evidentes.

Durante estadía en urgencias se mantiene estable. Se hospitaliza en UTAC para administración de pulsos de inmunoglobulina IV (FI 30/12).

Fecha Epicrisis : 08/01/2026 13:34

Ingresa a UTAC en similares condiciones, sin embargo el 31/12 evolucionó con deterioro significativo en lo motor, destacando hipofonía, aumento de cefaloparesia flexora y fatigabilidad generalizada, además de deterioro de PIM.

Dado lo anterior se inicia apoyo con CNAF y se decide traslado a UPC ante crisis miasténica inminente. Afortunadamente, logró recuperación rápida de fuerzas y de capacidad ventilatoria tras progresión de dosis de IgIV (FT 03/01), completando 5 días de tratamiento, no requiriendo intubación finalmente.

En lo neurológico con recuperación de fuerzas de forma progresiva y significativa, logrando levantarse con KNT y alimentación por vía oral sin incidentes. No fue necesario tampoco escalar a plasmaféresis.

Se mantuvo dosis de piridostigmina 120mg por 5 veces al día + prednisona 40mg/d + azatioprina 150mg/d sin cambios. En lo sistémico presentó hipokalemia leve, tratada con carga de potasio en 1 oportunidad, actualmente bien controlado. Sin otras interurrencias sistémicas por lo que se decide traslado a UTAC y posteriormente a sala de neurología.

Evolucionó clínicamente estable, sin nuevo deterioro neurológico ni quiebre clínico. Conversado con Dra. Izquierdo (tratante), se mantiene terapia de base y corticoides orales, con control ambulatorio programado para 22/01/2026.

Dada estabilidad clínica se decide alta hospitalaria y control ambulatorio por tratante.

Diagnósticos de egreso:

1.- Crisis Miasténica:

- IgIV x 5 días + CNAF.

- Inmunosuprimida: prednisona + AZA.

2.- Miastenia Gravis Generalizada (Ac. anti-receptor de acetilcolina positivo).

3.- Timoma operado (Tímectomía realizada el 26/05/2025).

Diagnóstico de Egreso

Miastenia Gravis - Crisis Miasténica

Miastenia gravis - Ac. anti-receptor de acetilcolina positivo

Timoma operado (Tímectomía realizada el 26/05/2025)

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

SV: estables.

Bien perfundida e hidratada.

Buen patrón respiratorio.

RR2TSS.

Abd blando indoloro.

EEII: sin TVP.

Mental: N. Sin disartria, sin voz nasal.

PC: sin fatigabilidad a la OCM, sin fatigabilidad sin paresia facial actual, sin paresia velopalatina.

Motor: fuerza M4+ EESS y M5 EEII, sin fatigabilidad, ROT vivos, plantares flexores.

Sens: simétrico sin extinción.

Cereb: N.

Exs.

- Lab (08/01): Hgma N, PCR <1, p. hepáticas N, coagulación N, crea 0.62 ELP N.

Plan Post Alta

Generales:

- Reposo relativo.

- Régimen liviano, hidratación abundante.

Medicamentos:

Fecha Epicrisis : 08/01/2026 13:34

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 08-01-2026 13:34:04

Página 3 de 3

- Piridostigmina 60mg, 2 comprimidos 5 veces al día VO (04 - 08 - 13 - 18 - 22 hrs) VO.
- Azatioprina 50 mg, 1 comprimido AM y 2 comprimidos PM VO.
- Prednisona 30 mg, 2 comprimidos al día VO.
- Omeprazol 20 mg, 1 comprimido al día VO.
- ElcalD, 1 comprimido al día VO.
- Cotrimoxazol forte, 1 comprimido al día VO, días Lunes-Miércoles-Viernes.
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos SOS (si dolor), máximo cada 8 hrs VO.

Controles médicos:

- Control por Neurología (Dra. Izquierdo) en CDT pasillo 9. Programado para 22/01/2026 a las 08:30 am.
- Control en CESFAM correspondiente para seguimiento y entrega de medicamentos.
- Consultar en servicio de urgencia en caso de síntomas de alarma (se educa).

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Daniel Antonio Candia Moya

INTERNO

Becado/Residente

Maria Ignacia Argandoña Moro

Médico Tratante (Staff)